



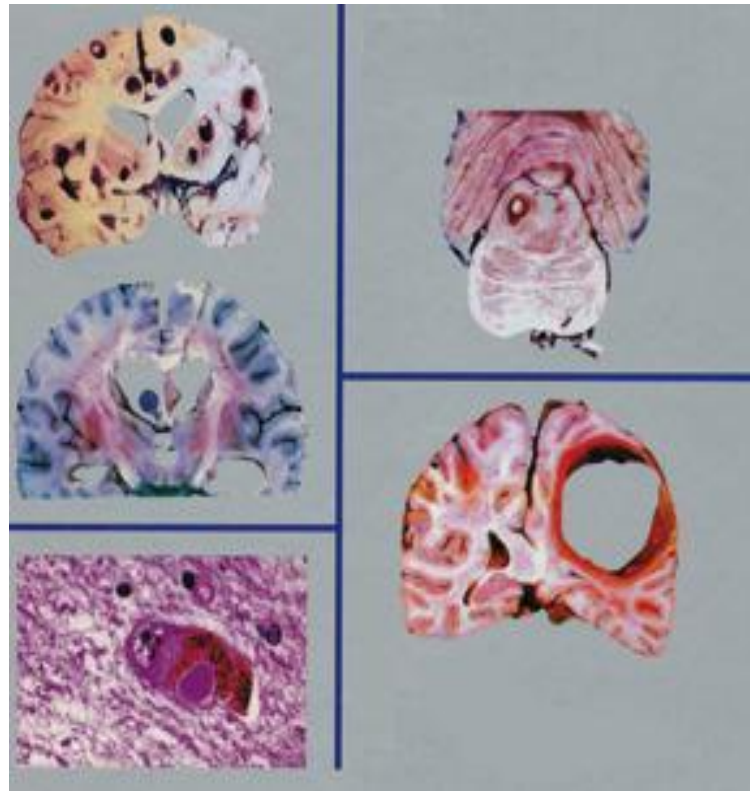
Universidad Nacional
Federico Villarreal

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO

Dra. Lucia Rodriguez Miranda



Universidad Nacional
Federico Villarreal





1. OBJETIVOS O LOGROS
2. INFECCIONES BACTERIANAS AGUDAS
3. INFECCIONES BACTERIANAS CRONICAS
4. INFECCIONES VIRALES



OBJETIVOS O LOGROS

1. QUE EL ALUMNO SEPA DIFERENCIAR UNA INFECCION AL SISTEMA NERVIOSO AGUDA DE UNA CRONICA
2. QUE EL ALUMNO SEPA ELEGIR CORRECTAMENTE EL EXAMEN DE AYUDA DIAGNOSTICA PRIORITARIA
3. EL ALUMNO SEPA ELEGIR EL TRAMIENTLO MAS PRECOZ POSIBLE.



MENINGITIS BACTERIANA

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. FIEBRE, CEFALEA, ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA, NAUSEAS, VOMITOS Y FOTOFobia
2. SIGNOS MENINGEOS
3. ATAXIA (NIÑOS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE)
4. CRISIS CONVULSIVAS (> NIÑOS)
5. DEFICIT NEUROLOGICOS FOCALES
6. NEUMONIA (NEUMOCOCO)
7. ERUPCIÓN PURPURICA (MENINGOCOCO)
8. ARTRITIS (HAEMOPHILUS INFLUENZAE)



MENINGITIS BACTERIANA

B. EXAMENES AUXILIARES

1. LCR TURBIO CON PRESION INCREMENTADA
2. > 1000 LEUCOCITOS/ mm³ DE PREDOMINIO POLIMORFONUCLEAR
3. ↓ GLUCOSA < 40 mg/ dL, a veces puede llegar a valores indetectables).
4. ↑ PROTEINAS >100 mg dL
5. CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA
6. TINCIÓN CON GRAM
7. DETECCION DE ANTIGENOS BACTERIANOS
8. HEMOGRAMA, UREA, CREATININA, CLUCOSA, EXAMEN DE ORINA
9. Rx DE TORAX, CRANEO Y SENOS PARANASALES
10. TAC, RMN (ANTES DEL P.L.)



MENINGITIS BACTERIANA

C. TRATAMIENTO ANTIBIOTICO

PRINCIPIOS BASICOS PARA ELECCION DE ANTIBIOTICO

a) PENETRACION AL SNC

- LA INFLAMACION MENINGEA > PENETRACION DE ANTIBIOTICOS

b) ACTIVIDAD BACTERICIDA

- ↓ DE PH
- ↑ PROTEINAS
- METABOLIZACION
- ANTAGONISMO

FARMACOLOGIA DE LOS ANTIBIOTICOS

1. PENICILINAS

- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD
 - ❖ REACCION EN ZONA DE INYECCION
 - ❖ TROMBOFLEBITIS
 - ❖ CRISIS EPILEPTICAS Y ENCEFALOPATIA TOXICA



MENINGITIS BACTERIANA

2. CEFALOSPORINAS

- TERCERA GENERACION: CEFOTAXIMA, CEFTRIAXONA, CEFTACIDIMA (MENINGOCOCO, NEUMOCOCO, H INFLUENZAE Y GRAM NEGATIVOS)
- BUENA CAPACIDAD DE PENTRACION EN LCR
- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD
 - ❖ NECROSIS TUBULAR
 - ❖ DIARREA

3. BETALACTAMICOS

- DISPONIBLES SOLO EN INTRAVENOSA
- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ NAUSEAS
 - ❖ VOMITOS
 - ❖ REACCION DE HIPERSENSIBILIDAD
 - ❖ ENCEFALOPATIA TOXICA



MENINGITIS BACTERIANA

4. AMINOGLUCOSIDOS

- CONCENTRACION EN LCR 25% DE LA PLASMATICA
- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ OTOTOXICIDAD
 - ❖ NEFROTOXICIDAD

5. CLORANFENICOL

- CONCENTRACION EN LCR 60% DE LA PLASMATICA
- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ SUPRESION DE LA MEDULA OSEA

6. METRONIDAZOL

- CONCENTRACION EFICAZ EN LCR TRAS ADMINISTRACION ORAL
- EFECTOS ADVERSOS:
 - ❖ CEFALEA, NAUSEAS, SEQUEDAD ORAL, SABOR METALICO.
 - ❖ NEUROTOXICIDAD



MIENINGITIS BACTERIANA

Tabla VI. Protocolo de manejo del paciente con sospecha de meningitis

- A** Mantener vía aérea permeable colocando al paciente en decúbito prono con la cabeza más baja que el cuerpo para prevenir aspiración. Si es necesario se procederá a intubación oral o endotraqueal.
- B** Colocar vía con suero fisiológico.
- C** Obtener muestras para hemocultivo, hemograma, pruebas de coagulación, bioquímica general y gasometría arterial.
- D** Iniciar tratamiento antibiótico empírico (véase Tabla VII).
- E** Colocar sonda vesical, medir diuresis.
- F** Realizar TAC craneal.
- G** Realizar punción lumbar.
- H** Realizar modificaciones al tratamiento antibiótico inicial según resultados del LCR.
- I** Obtener muestras para urocultivo y cultivo de lesiones dérmicas.
- J** Tratamiento sintomático de agitación (sedación), confusión (sonda nasogástrica por riesgo de aspiración), etc.
- K** ¿Administrar corticosteroides?



MENINGITIS BACTERIANA

TRATAMIENTO EMPÍRICO INICIAL Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO

- DEBE BASARSE EN LA EDAD Y POSIBLES PATOLOGÍAS PREVIAS, TENIENDO EN CUENTA EL RESULTADO DEL GRAM.
- EL TRATAMIENTO PUEDE MODIFICARSE CUANDO LOS RESULTADOS DE LOS CULTIVOS DE LCR O HEMOCULTIVOS ESTEN DISPONIBLES

DURACION DEL TRATAMIENTO

- PARA LA MENINGITIS MENINGOCOCICA PENICILINA POR 7 DIAS
- PARA LA MENINGITIS POR OTRAS BACTERIAS PENICILINA POR 10 A14 DIAS
- PARA LA MENINGITIS POR LISTERIA O ESTREPTOCOCOS POR 21 DIAS
- PARA LA MENINGITIS POR GRAMNEGATIVOS MINIMO 21 DIAS



MENINGITIS BACTERIANA

D. OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS

1. ESTEROIDES

- ANTES DE LA PRIMERA DOSIS DE ANTIBIOTICOS
- DEXAMETASONA
 - ✓ 0.15 mg/ kg. / 6 horas – adultos
 - ✓ 0.4 mg/ kg. / 12 horas – niños > de 2 meses
- SUSPENDER EN 05 A 10 DIAS

2. TRATAMIENTO SISTEMICO

- SHOCK
- HIDRATACION
- FIEBRE
- AISLAMIENTO

3. FACTORES PREDISPONENTES

- DE FOCOS INFECCIOSOS PARAMENINGEOS A DISTANCIA
- DE FISTULAS
- DERIVACIONES VENTRICULARES



MIENINGITIS BACTERIANA

E. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES

1. HIPERTENSION INTRACRANEAL

- BALANCE HIDRICO
- ESTEROIDE
- AGENTES HIPEROSMOLARES
 - ❖ MANITOL AL 20 %
 - ✓ 1 – 1.5 mg / kg. - C/ 4 horas →adultos
 - ✓ 0.25- 1 mg / kg.– niños
 - ❖ GLICEROL AL 20 %
 - ✓ 0..5 mg / kg. – c/ 4 horas

1. CRISIS CONVULSIVAS

2. HIDROCEFALIA

3. FIEBRE PERSISTENTE



ABSCESO CEREBRAL

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. CEFALEA
2. ALTERACION DE NIVEL DE CONCIENCIA DE GRADO VARIABLE
3. SIGNOS NEUROLÓGICOS FOCALES DEPENDIENTES DE LOCALIZACIÓN
4. SIGNOS GENERALES DE INFECCIÓN (FIEBRE, LEUCOCITOSIS, ESTÁN AUSENTES EN EL 50% DE CASOS)
5. CRISIS EPILEPTICAS PARCIALES O GENERALIZADAS
6. SIGNOS DE HIPERTENSION INTRACRANEANA



ABSCESO CEREBRAL

B. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

1. TAC
 - HIPODENSIDAD QUE CAPTA CONTRASTE → CEREBRITIS
 - CAPTACION EN ANILLO ABSCESO MADURO
2. RMN
 - T-1. HIPOINTENSIDAD CON CAPTACION DE CONTRASTE
 - T-2. AREA CENTRAL DE HIPERINTENSIDAD RODEADA DE CAPSULA HIPOINTENSA Y EDEMA HIPERINTENSO.
3. RX TORAX
 - FOCOS SEPTICOS PULMONARES
4. CULTIVO DE MATERIAL DEL ABSCESO



ABSCESO CEREBRAL

C. TRATAMIENTO ANTIBIOTICO

1. EL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DEBERIA SER LO MAS PRECOZ PARA EVITAR LA CIRUGIA
2. LA ELECCION EMPIRICA SE HACE EN FUNCION DE LA FUENTE DE ORIGEN DEL ABSCESO
3. EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS CONSIDERAR: HONGOS, PARASITOS.
4. EL TRATAMIENTO ESPECIFICO CON RESULTADOS DE CULTIVOS
5. SEGUIMIENTO CON NEUROIMAGENES.



ABSCESO CEREBRAL

D. TRATAMIENTO QUIRURGICO

1. SE DA CUANDO FRACASA EL TRATAMIENTO MEDICO.
 - a) DRENAJE QUIRURGICO CERRADO
 - b) CRANEOTOMIA ABIERTA CON ASPIRACION
 - c) TRATAMIENTO ANTIEDEMA
 - d) TRATAMIENTO ANTIEPILEPTICO
 - e) TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DEL FOCO INFECCIOSO PRIMARIO



TROMBOFLEBITIS DE SENOS VENOSOS

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. DEPENDE DEL SENO VENOSO AFECTADO

- SENO CAVERNOSO
 - ❖ EDEMA ORDINARIO Y CONGESTION VENOSA OCULAR
 - ❖ QUEMOSIS CONJUNTIVAL, EXOFTALMOS Y FOTOFOBIA
 - ❖ PARALISIS DE LOS PARES III, IV, VI y V1
- SENO LATERAL O TRANSVERSO
 - ❖ CEFALEA, PAPILEDEMA
 - ❖ PARALISIS V y VI
 - ❖ PARALISIS IX, X y XI



TROMBOFLEBITIS DE SENOS VENOSOS

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

- SENO LOGITUDINAL SUPERIOR
 - ❖ EDEMA FRENTE Y REGION ANTERIOR DEL CRANEO
 - ❖ CONVULSIONES O DEBILIDAD UNILATERALES
 - ❖ HEMIANOPSIA O CUADRANTANOPSIA HOMONIMAS
 - ❖ CONFUSION Y SINTOMAS DE HIPERTENSION INTRACRANEAL
 - ❖ APRAXIA Y AFASIA
 - ❖ PARALISIS DE LA MIRADA CONJUGADA



TROMBOFLEBITIS DE SENOS VENOSOS

B. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

1. ANGIORESONANCIA: ↑ DE SEÑAL DE SENO AFECTADO (MAS SENSIBLE QUE TAC)
2. ANGIOGRAFIA CONVENCIONAL SI HAY DUDA

C. TRATAMIENTO

1. ANTIBIOTICOS: SIMILAR AL DE ABSCESO
2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS: ANTIEDEMA, ANTIEPILEPTICOS
3. TRATAMIENTO DE FOCO INFECCIOSO PRIMARIO



MENINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

MENINGITIS TBC

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. ESTADIO I (PRODROMICO) :

SINTOMAS INESPECIFICOS POR 2 A MAS SEMANAS

- NIÑOS: APATIA, IRRITABILIDAD E INQUIETUD, CEFALEA, NAUSEAS, VOMITOS DOLOR ABDOMINAL, FEBRICULA INTERMITENTE.
- ADULTOS: LAXITUD, DEPRESION, CONFUSION, CAMBIOS DE CONDUCTA Y DE PERSONALIDAD.

1. ESTADIO II (INTERMEDIO):

a) IRRITACION MENINGEA

- FIEBRE
- CEFALEA Y VOMITOS
- SIGNOS MENINGEOS

b) PARALISIS DE NERVIOS CRANEALES

- SUELEN SER UNILATERALES
- LOS MAS AFECTADOS: VI, III, IV.



MENINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

3. ESTADIO III (GRAVE)

- CRISIS EPILEPTICAS
 - ❖ PARCIALES MAS FRECUENTES EN ADULTOS
 - ❖ GENERALIZADAS MAS FRECUENTES EN NIÑOS
- HIPERTENSION INTRACRANEAL
 - ❖ ↑ PERIMETRO CEFALICO Y FONTANELA EN LACTANTES
 - ❖ PAPIEDEMA EN ADULTOS
- DEFICIT MOTORES FOCALES

4. FACTORES PRONOSTICOS

- LA MENINGITIS TUBERCULOSA NO TRATADA ES MORTAL EN 3 U 8 SEMANAS
- EL RETRASO EN EL INICIO DE TRATAMIENTO ↑ EL RIESGO DE MUERTE O SECUELAS



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

B. EXAMEN RUTINARIO DE LCR.

1. ASPECTO CLARO TRANSPARENTE CON PRESION AUMENTADA
2. PLEOCITOSIS ESCASA < 500 LEUCOCITOS / mm³, 80 – 95 % LINFOCITOS
3. DISMINUCION DE GLUCOSA NO TAN MARCADA
4. HIPERPROTEINORRAQUIA 200 – 300 mg. / dL PUEDEN ALCANZAR CONCENTRACIONES DE 1000 – 1500 mg / dL

C. EXAMEN MICROBIOLOGICO.

1. ADA: SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD > 90 %
2. ANTICUERPOS CONTRA ANTIGENOS MYCOBACTERIUM POR ELISA
3. CULTIVO
4. REACCION EN CADENA DE POLIMERASA (PCR)



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

D. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

1. HIPONATREMIA E HIPOCLOREMIA , ANEMIA , ↑ VSG
2. PPD
3. RX TORAX
4. TAC Y RM: CAPTACION DE CONTRASTE QUE AFECTA A CISTERNAS BASALES; HIDROCEFALIA E INFARTOS ISQUEMICOS.



MENINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

TBC DEL SNC PARENQUIMATOSA

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

- LOS TUBERCULOMAS SE COMPORTAN COMO LESIONES FOCALES, NO SUELEN ACOMPAÑARSE DE FIEBRE
- EN 10 % COEXISTEN CON MENINGITIS TBC
- EN MENOS DEL 50 % HAY ANTECEDENTES DE TBC SISTEMICA
- ES MAS FRECUENTE EN PACIENTES CON VIH

B. EXAMENES COMPLEMENTARIOS

1. PPD (+ EN 50 – 70 %)
2. RX TORAX (50%)
3. TAC Y RM
 - LESIONES UNICAS HIPODENSAS O HIPOTENSAS
 - ABSCESOS
 - EVOLUCION



MENINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

C. TRATAMIENTO

1. PRIMERA LINEA

- ISONIACIDA
 - ❖ EFECTOS ADVERSOS:
 - ✓ HEPATICOS
 - ✓ NEUROLOGICOS
- RIFAMPICINA
 - ❖ EFECTOS ADVERSOS:
 - ✓ GASTROINTESTINALES
 - ✓ HEPATICOS
- PIRACINAMIDA
 - ❖ EFECTOS ADVERSOS:
 - ✓ HEPATOTOXICIDAD
 - ✓ HIPERURICEMIA



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

- ETAMBUTOL
 - ❖ EFECTOS ADVERSOS:
 - ✓ NEUROPATIA OPTICA
 - ✓ HIPERURICEMIA

2. SEGUNDA LINEA

- ESTREPTOMICINA
- AMIKAMICINA
- CICLOSERIA
- ETIONAMIDA



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

D. PAUTAS RECOMENDADAS

1. PACIENTES INMUNOCOMPETENTES:

SE ASOCIAN LOS 3 PRIMEROS

- ISONIACIDA
- RIFAMPICINA
- PIRACINAMIDA
- ETAMBUTOL O ESTREPTOMICINA (OPCIONAL)

2. PACIENTES INMUNOAFFECTADOS

SE ASOCIAN 4 FARMACOS

- ISONIACIDA
- RIFAMPICINA
- PIRACINAMIDA
- ETAMBUTOL



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

3. PACIENTES EN LOS QUE SE SOPECHA INCUMPLIMIENTO

ADMINISTRACION SUPERVISADA

- ISONIACIDA: 15 mg/ kg 2 VECES POR SEMANA
- RIFAMPICINA: 600 mg. 2 VECES POR SEMANA
- PIRACINAMIDA: 50 – 70 mg./kg 2 VECES POR SEMANA
- ETAMBUTOL: 50 mg. /kg 2 VECES POR SEMANA

4. PACIENTES QUE SE SOPECHA RESITENCIA

- ISONIACIDA
- RIFAMPICINA
- PIRACINAMIDA
- ETAMBUTOL O
- ESTREPTOMICINA



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

- a) USAR 4 FARMACOS POR 4 MESES, SEGUIDA DE ISONIACIDA Y RIFAMPICINA HASTA COMPLETAR 9 - 18 MESES
- b) SI APARECE RESISTENCIA DEBE REALIZARSE ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD

G. OTRAS MEDIDAS TERAPEUTICAS

1. CORTICOIDES EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- HIPERTENSION INTRACRANEAL
- ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA
- SIGNOS NEUROLÓGICOS FOCALES
- HIPERPROTEINORRAQUIA MARCADA O BLOQUEO ESPINAL



MENTINGITIS TUBERCULOSA Y NEUROTUBERCULOSIS

2. CIRUGIA

- HIDROCEFALIA
- TUBERCULOMAS
 - ❖ CON HIPERTENSION INTRACRANEAL QUE NO CEDE CON TRATAMIENTO
 - ❖ MALA RESPUESTA AL TRATAMIENTO
 - ❖ EPILEPSIA INTRATABLE
 - ❖ DIAGNOSTICO INCIERTO



INFECCIONES DEL SNC POR HONGOS

A. MANIFESTACIONES CLINICAS

LA MENINGITIS POR HONGOS SUELEN SER SUB AGUDAS.

1. SINDROME MENINGEO SUB AGUDO: SIMILAR AL DE LA TBC
2. AFECTACION SISTEMICA
 - PULMONAR
 - ✓ HISTOPLASMA, ASPERGILUS, BLASTOMICES.
 - CUTANEA
 - ✓ SPOROTRIX, PARACOCCIDIODES, BLASTOMICES.
 - OSEA
 - ✓ BLASTOMICES.
 - SENOS Y ORBITAS
 - ✓ MUCORMICOSIS, ASPERGILLUS.



INFECCIONES DEL SNC POR HONGOS

B. EXAMEN RUTINARIO DEL LCR

SIMILAR A LA MENINGITIS TUBERCULOSA.

1. ASPECTO CLARO TRANSPARENTE CON PRESION NORMAL O AUMENTADA
2. PLEOCITOSIS < 1000 CELULAS / mm³ - LINFOCITOS
3. HIPOGLUCORRAQUIA E HIPERPROTEINORRAQUIA

C. TEST SEROLOGICO DEL LCR

PUEDEN SE POSITIVOS EN SUERO U OTROS LIQUIDOS ORGANICOS

1. TEST DE PRECIPITINAS
2. ELISA
3. INMUNODIFUSION
4. TESTS DE FIJACION DE COMPLEMENTO
5. DETECCION DE ANTIGENOS MEDIANTE AGLUTINACION DE LATEX



INFECCIONES DEL SNC POR HONGOS

D. EXAMEN MICROBIOLOGICO DEL LCR

1. ANALISIS DEL SEDIMENTO: PERMITE VER INFECCION POR ASPERGILLUS
2. TINCION CON TINTA CHINA: PERMITE VER LEVADURAS ENCAPSULADAS
3. CULTIVO EN MEDIO SABOURAUD (GLUCOSA – AGAR)

E. OTROS EXAMENES COMPLEMENTARIOS

1. BIOPSIA Y EXAMEN DE LESIONES CUTANEAS
2. ASPIRACION Y CULTIVO DE LIQUIDO ARTICULAR
3. ANALISIS DE ORINA
4. HEMOCULTIVO Y CULTIVO DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA
5. Rx DE TORAX, CULTIVO DE ESPUTO Y BRONCOSCOPIA / BIOPSIA
6. GAMMAGRAFIA OSEA
7. TAC O RM DE CRANEO



INFECCIONES DEL SNC POR HONGOS

F. TRATAMIENTO

1. ANTIBIOTICOS ANTIFUNGICOS

- AMFOTERICINA B
- FLUCITOSINA
- AZOLES: KETOCONAZOL, FLUCONAZOL

G. OTRAS MEDIDAS TERAPEUTICAS

- 1. RESTAURAR LAS DEFENSAS DEL HUESPED CUANDO SEA POSIBLE**
- 2. RETIRAR CATETERES INTRAVENOSOS Y DERIVACIONES VENTRICULARES**
- 3. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION INTRACRANEAL**
- 4. CORTICOSTEROIDES**
- 5. TRATAMIENTO QUIRURGICO**
- 6. TRATAMIENTO PARA HIDROCEFALIA**



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

MENINGITIS

INFLAMACION DE ETIOLOGIA VIRICA Y CURSO AGUDO

A. ETIOLOGIA

1. ENTEROVIRUS (ECHO, COXSACKIE)
2. PAROTIDITIS, HERPES SIMPLE
3. ADENOVIRUS

SINO SE IDENTIFICA EL VIRUS SE HACE REFERENCIA A MENINGITIS ASEPTICA, FRECUENTE EN NIÑOS Y JOVENES, PREDOMINA EN EL VERANO

B. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. CEFALEA, FIEBRE Y SIGNOS MENINGEOS
2. MANIFESTACIONES SISTEMICAS
 - POLIOVIRUS: MIALGIAS, DEFICIT MOTOR, ARREFLEXIA
 - COXSACKIE: ARTROMIALGIAS
 - ECHO: EXANTEMAS PAPULOSOS



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

C. EXAMENES

1. LCR: PLEOCITOSIS MONONUCLEAR 300 CELULAS / mm³
 - GLUCOSA NORMAL
 - PROTEINAS NORMALES O LIGERAMENTE ELEVADAS
2. INMUNODIAGNOSTICO REACCION EN CADENA DE POLIMERASA

D. TRATAMIENTO

1. SINTOMATICOS
 - REPOSO
 - ANALGESICOS
 - ANTIPIRETICOS



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

ENCEFALITIS

ENCEFALITIS ES UNA ENFERMEDAD INFLAMATORIA CEREBRAL CON NECROSIS NEURONAL

A. ETIOLOGIA

1. VIRUS ARN: PICORNAVIRUS, ENTEROVIRUS
2. VIRUS ADN: HERPES ADENOVIRUS

B. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. FIEBRE Y SINDROME MENINGEO DE INICIO AGUDO
2. ALTERACION DE CONCIENCIA, CRISIS EPILEPTICAS, DEFICIT FOCALES.

C. EXAMENES

1. LCR: SIMILAR AL DE MENINGITIS VIRAL
2. INMUNODIAGNOSTICO
3. BIOPSIA CEREBRAL
4. EEG, TAC y RM



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

D. TRATAMIENTO

1. SINTOMATICOS
 - HIPERTENSION INTRACRANEAL:
 - ❖ AGENTES HIPEROSMOLARES
 - ❖ -ESTEROIDES
 - CRISIS
 - ❖ ANTIEPILEPTICOS
2. AGENTES ANTIVIRALES



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

ENCEFALITIS HERPETICA

ES LA MAS FRECUENTE, SIN TRATAMIENTO TIENE UNA ALTA MORTABILIDAD

A. ETIOLOGIA

1. HERPES SIMPLE TIPO 1

B. MANIFESTACIONES CLINICAS

1. INICIO SUB AGUDO CON FIEBRE, CEFALEA Y ALTERACION DE CONCIENCIA
2. INFECTA A REGIONES TEMPORALES: ALUCINACIONES, DEFICIT FOCALES Y CRISIS
3. SINTOMATOLOGIA MUY FRECUENTE:
 - ❖ ALTERACION DEL NIVEL DE CONCIENCIA
 - ❖ FIEBRE
 - ❖ CAMBIOS DE PERSONALIDAD
 - ❖ CEFALEA
 - ❖ DISFASIA



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

C. EXAMENES

1. LCR NORMAL
2. PCR EN LCR
3. EEG : DESCARGAS EPILEPTICAS LATERALIZADAS PERIODICAS
4. TAC – RM: LESIONES EN LOBULO TEMPORAL Y REGION FRONTOORBITARIA
5. BIOPSIA CEREBRAL

D. TRATAMIENTO

1. ACICLOVIR 10 mg /kg. CADA 8 HORAS ENDOVENOSO DE 14 A 21 DIAS
2. COTICOIDES
3. ANTIEPILEPTICOS
4. ASISTENCIA RESPIRATORIA



INFECCIONES VIRICAS DEL SNC

Tabla IV. Características del LCR en las infecciones del SNC

	Meningitis purulenta	Meningitis linfocitaria	Meningitis linfocitaria
<i>Clínica</i>	Aguda	Aguda/subaguda	Subaguda/crónica
<i>Etiología</i>	Causas infecciosas (bacterias, endocarditis, fase precoz de tuberculosis)	Causas infecciosas (virus, bacterias parcialmente tratadas, tuberculosis, hongos, <i>Leptospira</i> , <i>Borrelia</i> , sífilis, focos parameningeos, etc.)	Causas infecciosas (tuberculosis, hongos, <i>Brucella</i> , sífilis, <i>Borrelia</i> , parásitos, algunos virus, etc.)
<i>Aspecto</i>	Turbio	Claro	Claro u opalino (xantocrómico si la concentración de proteínas es muy grande)
<i>Células</i>	+++ (500-10.000; polinucleares)	+ (10-1.000; mononucleares)	++ (25-500; mononucleares)
<i>Glucosa</i>	Muy disminuida (próxima a 0 mg/dL)	Normal o disminuida	Disminuida (normal al inicio)
<i>Proteínas</i>	+++ (100-700 mg/dL)	Normal o aumentada (<100 mg/dL)	++ (50-500 mg/dL)

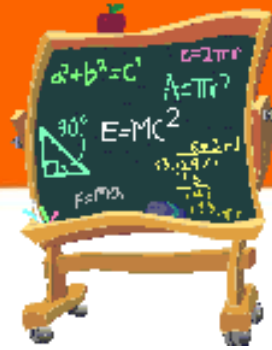
BIBLIOGRAFIA

Allan Ropper, Martin Samuels, Joshua Klein, Sashank Prasad. ADAMS R. 2011 – 9º Edición Principles of Neurology. Edición Kindle. 22 de mayo de 2019. ISBN-13: 978-0071842617

Van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect. 2016;22 Suppl 3:S37-S62. doi:10.1016/j.cmi.2016.01.007.

Thwaites GE. Advances in the diagnosis and treatment of tuberculous meningitis. Curr Opin Neurol. 2013;26(3):295-300. doi:10.1097/WCO.0b013e3283602814.

Bilgrami M, O'Keefe P. Neurologic diseases in HIV-infected patients. Handb Clin Neurol. 2014;121:1321-1344. doi:10.1016/B978-0-7020-4088-7.00090-0.



ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL SISTEMA NERVIOSO

Dra. Lucia Rodriguez Miranda

